BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG
TỔ THÔNG TIN THUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Trung, ngày 05 tháng 10 năm 2026

THÔNG TIN THUỐC
BRAVINE INMED

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC THUỐC:

Mỗi 5ml hỗn dịch đã pha chứa:

Thành phần dược chất Cefdinir.....125 mg.

Thành phần tá dược: đường trắng, aspartam, comprecel 112, natri carboxymethyl cellulose, bột mùi dâu, màu ponceau 4R (E124).

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha hỗn dịch

Mô tả: Bột màu trắng đến trắng ngà, khô tơi, không bị vón, ẩm mốc, màu sắc đồng nhất, có mùi thơm nhẹ.

CHỈ ĐỊNH:

Cefdinir được chỉ định điều trị các bệnh nhiễm trùng do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra.

Người lớn và trẻ vị thành niên:

- Viêm phổi mắc phải ở cộng đồng.
- Đợt cấp của viêm phế quản mạn tính.
- Viêm xoang hàm trên cấp tính.
- Viêm họng/ viêm amidan.
- Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng.

Trẻ em:

- Viêm tai giữa cấp.
- Viêm xoang hàm trên cấp.
- Viêm họng / viêm amidan.

Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:

Liều lượng:

Tổng liều hàng ngày cho tất cả các nhiễm trùng là 14 mg/kg, tối đa là 600 mg mỗi ngày.

Cefdinir có thể uống vào bất kỳ thời điểm nào không liên quan tới bữa ăn.

Trẻ em (từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi)		
Loại nhiễm trùng	Liều dùng	Thời gian điều trị
Viêm tai giữa cấp	7 mg/kg mỗi 12h hoặc14 mg/kg mỗi 24h	5 - 10 ngày 10 ngày
Viêm xoang hàm trên cấp tính	7 mg/kg mỗi 12h hoặc14 mg/kg mỗi 24h	10 ngày 10 ngày
Viêm họng / viêm amidan	7 mg/kg mỗi 12h hoặc14 mg/kg mỗi 24h	5 - 10 ngày 10 ngày
Nhiễm khuẩn da và cấu trúc da không biến chứng	7 mg/kg mỗi 12h	10 ngày

Bảng liều dùng theo cân nặng:

Cân nặng	Liều dùng
9 kg	2,5ml /12 giờ hay 5 ml /24 giờ
18 kg	5ml /12 giờ hay 10 ml /24 giờ
27 kg	7,5ml /12 giờ hay 15 ml/24 giờ
36 kg	10ml /12 giờ hay 20 ml/24 giờ
≥ 43 kg	12ml /12 giờ hay 24 ml /24 giờ

Trẻ em ≥ 43 kg dùng liều tối đa mỗi ngày là 600 mg.

Bệnh nhân thẩm tách máu: Do thẩm tách máu làm thải trừ cefdinir từ cơ thể, đối với bệnh nhân thẩm tách mãn tính thì liều khởi đầu là 300 mg và duy trì ở liều 7 mg/kg/ngày.

Bệnh nhân suy thận: Với bệnh nhi có thanh thải creatinin < 30ml/phút, liều cefdinir là 7mg/kg mỗi lần/ngày (tối đa 300mg).

Cách dùng:

- Lắc lọ trước khi pha.

- Thêm nước đun sôi để nguội đến vạch, lắc đều. Tiếp tục bổ sung nước đến vạch (nếu cần), lắc thật kỹ.

- Sau khi pha, hỗn dịch có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng (20 - 25°C). Lọ phải được nắp kín và lắc kỹ trước mỗi lần dùng thuốc.

- Hỗn dịch chỉ có thể sử dụng trong vòng 10 ngày kể từ khi pha.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với cefdinir hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Bệnh nhân dị ứng với các kháng sinh cephalosporin.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC:

* Trong sử dụng:

- Tính an toàn và hiệu quả ở trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi chưa được xác định. Không nên sử dụng Bravine Inmed trên đối tượng này.

- Người có tiền sử quá mẫn cảm với nhóm penicillin.

- Người có khuynh hướng cá nhân hoặc ở gia đình có phản ứng dị ứng, như bị hen phế quản, phát ban hoặc mề đay.

- Người có rối loạn về thận. Giảm liều khi suy thận với creatinin < 30ml/phút.

- Thận trọng cho các bệnh nhân có tiền sử viêm ruột.

- Thận trọng với bệnh nhân tiểu đường: thuốc có chứa sucrose, bệnh nhân có các vấn đề về di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose - galactose hoặc thiếu hụt sucrase - isomaltase không nên dùng thuốc này.

- Thuốc có aspartam chứa phenylalanin có thể có hại cho người mắc bệnh phenylceton niệu.

- Thuốc có chứa màu ponceau 4R có thể gây dị ứng.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Phụ nữ có thai: Tác dụng gây quái thai: loại B.

Cefdinir không gây quái thai ở chuột, liều uống đến 1000 mg / kg / ngày hoặc ở thỏ với liều uống đến 10 mg / kg / ngày. Độc tính trên mẹ (giảm cân) được thấy ở thỏ với liều dung nạp tối đa 10 mg / kg / ngày mà không có tác dụng phụ trên con. Giảm cân xảy ra ở bào thai chuột với liều ≥100 mg/kg/ ngày, ở chuột con≥32 mg/kg/ngày.

Tuy nhiên, không có những nghiên cứu đầy đủ và kiểm soát tốt ở phụ nữ có thai. Vì vậy, chỉ nên sử dụng thuốc này trong thời kỳ mang thai nếu thật sự cần thiết.

Phụ nữ cho con bú: Sau khi dùng liều duy nhất 600 mg, cefdinir không thấy phát hiện trong sữa mẹ.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng lên khả năng lái máy móc, tàu xe. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được cảnh báo rằng tác dụng không mong muốn như chóng mặt có thể xảy ra.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC:

- Antacid: Dùng đồng thời viên nang cefdinir 300 mg với 30 ml dung dịch huyền phù Maalox (antacid) làm giảm Cmax và AUC khoảng 40%, thời gian đạt C_{max} kéo dài thêm 1h. Nếu phải dùng antacid khi điều trị với cefdinir, thì nên dùng cefdinir trước hay sau khi dùng các thuốc kháng acid khoảng 2 giờ.

- Probenecid: có thể ức chế bài tiết cefdinir qua thận, kết quả làm tăng gấp đôi AUC, tăng 54% nồng độ cefdinir trong huyết tương và tăng 50% thời gian bán thải t1/2.

- Chế phẩm chứa sắt:

+ Phối hợp cefdinir với thuốc trị liệu có chứa 60 mg sắt (FeSO4) hoặc các vitamin chứa 10 mg sắt làm giảm hấp thu cefdinir lên 80% và 31%. Nếu cần bổ sung sắt khi điều trị với cefdinir, cefdinir nên được dùng ít nhất trước hoặc sau 2 giờ khi bổ sung sắt.

+ Tác động của thực phẩm tăng cường sắt đối với sự hấp thu cefdinir chưa được nghiên cứu.

+ Dùng đồng thời với sữa bột công thức bổ sung sắt không ảnh hưởng đáng kể đến được động học của cefdinir. Do đó, cefdinir có thể dùng cùng với sữa bột công thức bổ sung sắt.

+ Đã có báo cáo về phân màu đỏ ở bệnh nhân dùng cefdinir với các chế phẩm chứa sắt. Màu đỏ là do sự hình thành của phức hợp không hấp thu giữa cefdinir hoặc các sản phẩm chuyển hóa của nó với sắt.

- Tương tác với các xét nghiệm: phản ứng dương tính giả với ceton trong nước tiểu có thể xảy ra khi các xét nghiệm sử dụng nitroprussid. Sử dụng cefdinir có thể gây phản ứng dương tính giả với glucose trong nước tiểu khi xét nghiệm sử dụng thuốc thử Clinitest, dung dịch Benedict hoặc dung dịch Fehling. Khuyến cáo các xét nghiệm glucose nên dựa trên phản ứng của enzym glucose oxidase như Clinistix hoặc Tes - Tape.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

- Trong các thử nghiệm lâm sàng, 2289 bệnh nhân nhỏ (1783 ở Mỹ và 506 không ở Mỹ) được điều trị với liều khuyến cáo của bột pha hỗn dịch cefdinir (14 mg / kg / ngày). Hầu hết các phản ứng phụ đều nhẹ và tự khỏi, không có người chết hoặc tàn tật vĩnh viễn do cefdinir. Trong đó, 2% bệnh nhân ngưng dùng thuốc do các tác dụng phụ, chủ yếu do rối loạn đường tiêu hóa, thường là tiêu chảy. 0,2% bệnh nhân ngưng do phát ban liên quan đến cefdinir.

Tác dụng không mong muốn khi sử dụng bột pha hỗn dịch Cafdinir trong thử nghiệm lâm sàng trên 1783 bệnh nhân nhà ở Mỹ "		
	Tiêu chảy	8%

Tỷ lệ mắc ≥ 1%	Phát ban	3%
	Nôn	1%
0.1% < Tỷ lệ mắc <1%	Candida da	0.9%
	Đau bụng	0.8%
	Giảm bạch cầu	0.3%
	Candida âm đạo	0.3% nữ
	Viêm âm đạo	0,3% nữ
	Phân bất thường	0.2%
	Khó tiêu	0.2%
	Huyết áp cao	0.2%
	Tăng AST	0.2%
	Ban da	0.2%
	Buồn nôn	0.2

(*):977 nam, 806 nữ

- Tác dụng không mong muốn hậu marketing:

Các tác dụng không mong muốn sau đã được báo cáo trong quá trình lưu hành thuốc ngoài thị trường: sốc, sốc phản vệ hiếm có trường hợp tử vong, phù mặt và thanh quản, khó thở, phản ứng giống bệnh huyết thanh, viêm kết mạc, viêm miệng, hội chứng Stevens - Johnson, hội chứng hoại tử thượng bì do nhiễm độc, viêm da tróc vảy, ban đỏ đa dạng, hồng ban, viêm gan cấp, ở mật, viêm gan virut ác tính, suy gan, vàng da, tăng amylase, viêm ruột cấp, tiêu chảy ra máu, viêm đại tràng xuất huyết, đại tiện máu đen, viêm đại tràng giả mạc, giảm toàn bộ huyết cầu, giảm bạch cầu hạt, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát, thiếu máu tan máu, suy hô hấp cấp, hen suyễn, viêm phổi do thuốc gây ra, viêm phổi tăng bạch cầu ưa eosin, viêm phổi kẽ tự phát, sốt, suy thận cấp, nguy cơ chảy máu, rối loạn đông máu, hội chứng đồng máu rải rác nội mạch, chảy máu dạ dày, loét dạ dày, tắc ruột, mất ý thức, viêm mạch dị ứng, suy tim, tức ngực, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, vận động không tự chủ, tiêu cơ vân.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Không có thông tin về quá liều cefdinir ở người. Trong các nghiên cứu độc tính ở loài gặm nhấm, một liều duy nhất 5600 mg / kg đường uống không gây ra tác dụng phụ.

Các dấu hiệu và triệu chứng quá liều sau khi dùng thuốc kháng sinh ß - lactam khác bao gồm buồn nôn, nôn mửa, đau thượng vị tiêu chảy và co giật.

Xử trí: Thẩm phân tách máu loại bỏ cefdinir khỏi cơ thể. Điều này có ích trong trường hợp có phản ứng quá liều nghiêm trọng, đặc biệt nếu chức năng thận bị tổn hại.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

- Cơ chế tác dụng: Cefdinir là một kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin thế hệ 3. Tác dụng diệt khuẩn của cefdinir là do ức chế sự tổng hợp vách tế bào của vi khuẩn. Cefdinir bền vững cao với một số enzym beta – lactamase, do vậy nhiều chủng vi khuẩn kháng penicilin và một vài cephalosporin có thể vẫn nhạy cảm Cefdinir.

- Cơ chế đề kháng: chủ yếu qua sự thủy phân bởi một số ß- lactamase, biến đổi các protein liên kết với penicillin (PBPs) hoặc làm giảm tinh thấm vào tế bào của thuốc, Cefdinir bất hoạt đối với hầu hết các chủng Enterobacterspp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., Streptococcus kháng penicillin và Staphylococcus kháng meticillin. H. Influenzae tiết ß - lactamase kháng ampicillin thường không nhạy cảm với cefdinir.

– Cefdinir có hoạt tính đối với hầu hết các chủng vi khuẩn Gram (-) và Gram (+), cả in vitro và trên điều trị lâm sàng:

+ Vi khuẩn Gram dương: Staphylococcus aureus (chỉ những chủng còn nhạy cảm với methicillin), Streptococcus pneumoniae (chỉ những chủng còn nhạy cảm với penicillin), Streptococcus pyogenes.

+ Vi khuẩn Gram âm: Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis.

- Cefdinir có nồng độ ức chế tối thiểu in vitro (MICs) ở mức 1 µg / ml đối với các vi sinh vật sau. Tuy nhiên, sự an toàn và hiệu quả của cefdinir trong điều trị lâm sàng chưa được thiết lập trong các thử nghiệm lâm sàng đầy đủ và được kiểm soát tốt:

+ Vi khuẩn Gram dương: Staphylococcus epidermidis (chỉ chủng còn nhạy cảm với methicillin) Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans.

+Vi khuân Gram âm: Citrobacter koseri, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu: Thời gian đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương khoảng 2 - 4 giờ sau khi dùng viên nang hoặc bột pha hỗn dịch. Sinh khả dụng ước tính là 21% sau khi uống 1 liều 300mg, và 16% sau khi uống 1 liều 600mg. Sinh khả dụng tuyệt đối

của cefdinir bột pha hỗn dịch là 25%. Cefdinir được dùng vào bất kỳ thời điểm nào không phụ thuộc vào bữa ăn.

Nồng độ cefdinir trong huyết tương và các giá trị được động học sau khi dùng cefdinir liều đơn 7 và 14 mg / kg cefdinir cho trẻ em (từ 6 tháng đến 12 tuổi) được trình bày trong bảng sau:

Giá trị trung bình thông số dược động học Cefdinir sau khi dùng thuốc cho trẻ em (Mean ± SD)

Liều	Cmax (µg/ml)t	max (h)	AUC (µg.h/ml)
7 mg/kg	2.3 (0.65)	2.2 (0.6)	8.31 (2.5)
14 mg/kg	3.86 (0.62)	1.8 (0.4)	13.4 (2.64)

Phân bố: Thể tích phân bố trung bình (Vd) của cefdinir ở người trưởng thành là 0,35 l/kg; ở trẻ em (6 tháng đến 12 tuổi) Vd là 0,67 V/kg. Cefdinir gắn với protein huyết tương khoảng 60 - 70% ở cả người lớn và trẻ em, không phụ thuộc nồng độ.

Chuyển hóa và thải trừ: cefdinir hầu như không bị chuyển hóa. Cefdinir được thải trừ chủ yếu qua thận với thời gian bán thải là 1,7 (± 0,6) giờ. Ở những người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, độ thanh thải là 2,0 ml/phút/kg và giảm ở bệnh nhân suy thận. Cần điều chỉnh liều ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận hoặc đang thẩm tách máu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 30ml, Lọ 40ml, Lọ 50ml.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C.

HẠN DÙNG: 18 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: TCCS.

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I-PHARBACO

160 Tôn Đức Thắng - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 024 – 38454561; 024 - 38454562 Fax: 024 - 38237460

Sản xuất tại: Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

WPBC.SPC22001104

Mọi thông tin cần cung cấp thêm xin chủ động liên hệ bộ phận Dược lâm sàng Thông tin thuốc

TỔ THÔNG TIN THUỐC